

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

Esta guía reúne los péptidos que Peptigene maneja, organizados por objetivo. Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y —de forma destacada— sus contraindicaciones y los criterios de aptitud. El propósito es que dispongas de información clara y completa para conversarla con un profesional de la salud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis indicadas son rangos de referencia y deben individualizarse. La información aquí contenida no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

Objetivos incluidos en esta guía

- **Pérdida de peso y control metabólico** — Semaglutida, Tirzepatida, Retatrutida, Cagrilintida
- **Antienvejecimiento, longevidad y recomposición** — NAD⁺, GHK-Cu, Epitalón, Tesamorelina, Ipamorelina, CJC-1295, BPC-157, TB-500
- **Salud hormonal y sexual** — Kisspeptina, PT-141 (Bremelanotida)
- **Función cognitiva y neuroprotección** — Semax, Selank

PÉRDIDA DE PESO Y CONTROL METABÓLICO · Agonistas de incretinas y amilina

Semaglutida · Agonista GLP-1 · semanal

Qué es. Análogo del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), de aplicación semanal. Es la molécula base de las terapias de pérdida de peso más usadas del mundo.

Cómo funciona. Imita la incretina GLP-1: potencia la secreción de insulina dependiente de glucosa, suprime el glucagón, ralentiza el vaciado gástrico y actúa en los centros hipotalámicos del apetito reduciendo el hambre.

Beneficios

- Pérdida de peso sostenida de alrededor del 15% del peso corporal.
- Mejor control glucémico y reducción de la HbA1c.
- Disminución marcada del apetito y los antojos.
- Beneficio cardiovascular demostrado y mejora de presión y lípidos.

Dosis habitual	0.25 → 1.0–2.4 mg/sem (escalada)	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno a las 12–16 sem
Dosis mínima	0.25 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Antecedente personal o familiar de carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis previa, embarazo y lactancia. Precaución en enfermedad digestiva grave y retinopatía diabética.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2, previa valoración médica. No apto en las contraindicaciones anteriores.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

Tirzepatida · Doble agonista GIP/GLP-1 · semanal

Qué es. Doble agonista de los receptores de GIP y GLP-1 de aplicación semanal, con uno de los perfiles de eficacia más altos disponibles.

Cómo funciona. Activa simultáneamente las vías GIP y GLP-1, con efecto sinérgico sobre la saciedad, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas.

Beneficios

- Pérdida de peso superior, en torno al 20–22% del peso corporal.
- Control glucémico potente en diabetes tipo 2.
- Mejora de perfil lipídico y presión arterial.
- Reducción sostenida del apetito.

Dosis habitual	2.5 → 5–15 mg/sem (escalada)	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno ≥ 12 sem
Dosis mínima	2.5 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo y lactancia. Precaución digestiva y en diabetes con retinopatía.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad o diabetes tipo 2 bajo control médico. No apto en las contraindicaciones señaladas.

Retatrutida · Triple agonista GIP/GLP-1/glucagón · en fase 3

Qué es. Triple agonista (GIP, GLP-1 y receptor de glucagón) en investigación clínica avanzada. Aún no aprobado; los datos provienen de ensayos.

Cómo funciona. Suma la activación del receptor de glucagón —que aumenta el gasto energético y la oxidación de grasa— a los efectos de saciedad de GIP y GLP-1.

Beneficios

- La mayor pérdida de peso reportada hasta la fecha (~24% a 48 semanas en fase 2).
- Fuerte mejora metabólica global.
- Reducción de grasa hepática y visceral.

Dosis habitual	Escalada hasta 8–12 mg/sem (en ensayos)	Duración sugerida	En estudio; protocolos de 48+ sem
Dosis mínima	1–2 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Mismo perfil que los GLP-1. Al ser experimental, únicamente en contexto clínico supervisado.

¿Es apto para el tratamiento? Compuesto en evaluación clínica, no aprobado para uso general; sólo bajo protocolo médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

Cagrilintida · Análogo de amilina de larga acción · semanal

Qué es. Análogo sintético de larga acción de la amilina, hormona co-secretada con la insulina. Potencia a los GLP-1 cuando se combina (CagriSema / IcoSema).

Cómo funciona. Agonista de los receptores de amilina en el área postrema; reduce el apetito por una vía distinta y complementaria a la del GLP-1 y ralentiza el vaciado gástrico.

Beneficios

- Hasta ~10.8% de pérdida de peso en monoterapia.
- Hasta ~25.2% combinada con semaglutida.
- Control del hambre por un mecanismo aditivo al GLP-1.
- Mejora del control glucémico postprandial.

Dosis habitual	0.3 → 2.4 mg/sem (escalada)	Duración sugerida	Crónico; escalada de 12+ sem
Dosis mínima	0.3 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución digestiva. Evitar combinaciones sin control médico.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad, sola o combinada con un GLP-1, bajo supervisión.

ANTIENVEJECIMIENTO, LONGEVIDAD Y RECOMPOSICIÓN · Regeneración, eje GH e IGF-1

NAD+ · Coenzima celular · energía y reparación

Qué es. Dinucleótido de nicotinamida y adenina, coenzima esencial de todas las células cuyos niveles descienden con la edad.

Cómo funciona. Cofactor central de la producción de energía (ATP), activa las sirtuinas y las enzimas PARP de reparación del ADN y regula el ritmo circadiano.

Beneficios

- Más energía y claridad mental.
- Apoyo a la función mitocondrial y a la reparación celular.
- Mejor recuperación y tolerancia al estrés metabólico.

Dosis habitual	50–100 mg SC; protocolos IV 250–500 mg	Duración sugerida	Por ciclos: carga inicial y mantenimiento
Dosis mínima	50 mg	Vía	Subcutánea o intravenosa

Contraindicaciones. Sin datos suficientes en embarazo y lactancia. La vía IV rápida puede causar molestias; debe administrarse lentamente.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos que buscan apoyo energético y de longevidad; evaluación previa si hay enfermedad de base.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

GHK-Cu · Péptido de cobre · piel y regeneración

Qué es. Tripéptido-cobre presente de forma natural en el organismo, usado por vía tópica e inyectable.

Cómo funciona. Estimula la síntesis de colágeno y elastina, remodela la matriz extracelular y aporta acción antioxidante, antiinflamatoria y favorecedora de la cicatrización.

Beneficios

- Piel más firme y reducción visible de arrugas.
- Mejora de la cicatrización y la calidad del cabello.
- Apoyo a la recuperación de tejidos.

Dosis habitual	Tópico 1–2%; SC 1–2 mg/día en ciclos	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 semanas con descanso
Dosis mínima	1 mg/día (o tópico)	Vía	Tópica o subcutánea

Contraindicaciones. No aplicar sobre heridas infectadas; precaución en trastornos del metabolismo del cobre; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos que buscan cuidado dérmico y regeneración; no apto con alergia al cobre.

Epitalón · Tetrapéptido pineal · longevidad

Qué es. Péptido sintético derivado de la epitalamina de la glándula pineal, orientado a longevidad. Datos mayormente preclínicos.

Cómo funciona. Estimula la enzima telomerasa (mantenimiento de los telómeros) y normaliza la producción de melatonina, regulando el eje pineal y el ritmo circadiano.

Beneficios

- Apoyo a la longevidad y el mantenimiento celular.
- Mejora de la calidad del sueño.
- Efecto antioxidante y regulación circadiana.

Dosis habitual	5–10 mg/día en ciclos de 10–20 días	Duración sugerida	Ciclos cortos, 1–2 veces al año
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Evitar en embarazo, lactancia y antecedente de cáncer activo; evidencia clínica aún limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en longevidad; requiere criterio médico por su carácter experimental.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

Tesamorelina · Análogo de GHRH · grasa visceral

Qué es. Análogo de la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH), con uso clínico aprobado para reducir grasa visceral en lipodistrofia.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis para que libere hormona de crecimiento de forma pulsátil y fisiológica, elevando el IGF-1.

Beneficios

- Reducción notable de la grasa visceral abdominal.
- Apoyo a la recomposición corporal.
- Posible mejora cognitiva y de perfil lipídico.

Dosis habitual	1–2 mg/día SC (preferente en la noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses con evaluación
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria. Precaución en diabetes (puede elevar la glucosa).

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con exceso de grasa visceral, previa valoración; no apto con cáncer activo o durante el embarazo.

Ipamorelina · Secretagogo de GH selectivo

Qué es. Pentapéptido secretagogo de hormona de crecimiento, selectivo y bien tolerado, agonista del receptor de ghrelina.

Cómo funciona. Induce la liberación pulsátil de GH sin elevar de forma significativa el cortisol ni la prolactina; sinergiza con un análogo de GHRH.

Beneficios

- Mejor recuperación y sueño profundo.
- Apoyo a la recomposición corporal y a la piel.
- Sin gran estímulo del apetito, a diferencia de otros secretagogos.

Dosis habitual	200–300 mcg, 1–3 veces al día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 semanas con descanso
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo. Precaución con alteraciones endocrinas.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos enfocados en recuperación y composición corporal; no apto con cáncer activo.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

CJC-1295 · Análogo de GHRH · sinergia con ipamorelina

Qué es. Análogo de GHRH de acción prolongada, habitualmente combinado con ipamorelina para potenciar el eje de la hormona de crecimiento.

Cómo funciona. Eleva de forma sostenida los niveles basales de GH e IGF-1; la variante con DAC prolonga su vida media a varios días.

Beneficios

- Mayor síntesis proteica y recuperación.
- Apoyo a la pérdida de grasa y a la recomposición.
- Mejora de la calidad del sueño y de la piel.

Dosis habitual	100 mcg (sin DAC) con ipamorelina; DAC 1–2 mg/sem	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 semanas
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; precaución en diabetes por su efecto sobre GH/IGF-1.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos, junto a ipamorelina, bajo supervisión; no apto con cáncer activo.

BPC-157 · Péptido de reparación · recuperación

Qué es. Péptido de origen gástrico ampliamente usado para recuperación de tejidos. Evidencia principalmente preclínica.

Cómo funciona. Favorece la angiogénesis, la migración celular y la reparación de tendones, ligamentos, músculo y mucosa digestiva; modula factores de crecimiento.

Beneficios

- Acelera la recuperación de lesiones musculotendinosas.
- Apoyo a la salud digestiva e intestinal.
- Efecto antiinflamatorio local.

Dosis habitual	250–500 mcg, 1–2 veces al día	Duración sugerida	Ciclos de 2–6 semanas según la lesión
Dosis mínima	250 mcg/día	Vía	Subcutánea (local o sistémica)

Contraindicaciones. Evitar en cáncer activo y embarazo por falta de datos; evidencia clínica limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en fase de recuperación o rehabilitación, con criterio médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

TB-500 · Fragmento de timosina $\beta 4$ · reparación

Qué es. Fragmento sintético de la timosina beta-4, orientado a reparación y flexibilidad de tejidos. Evidencia mayormente preclínica.

Cómo funciona. Regula la actina, promueve la migración celular, la angiogénesis y la reducción de la inflamación y de adherencias.

Beneficios

- Apoyo a la recuperación muscular y articular.
- Mejora de la flexibilidad y del rango de movimiento.
- Efecto sistémico de reparación.

Dosis habitual	2–2.5 mg, 2 veces/sem (carga), luego mantenimiento	Duración sugerida	Carga 4–6 sem, mantenimiento periódico
Dosis mínima	2 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; datos clínicos limitados.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con lesiones o alto desgaste físico, bajo supervisión.

SALUD HORMONAL Y SEXUAL · Eje reproductivo y deseo

Kisspeptina · Regulador del eje reproductivo

Qué es. Neuropeptido que actúa como regulador maestro del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, estimulando la cascada hormonal en su origen.

Cómo funciona. Activa el receptor KISS1R en las neuronas GnRH del hipotálamo, desencadenando la liberación pulsátil de GnRH y, en consecuencia, de LH y FSH.

Beneficios

- Estimula la producción endógena de testosterona por vía fisiológica.
- Apoya la fertilidad y preserva la función gonadal.
- Mejora de la libido y de la respuesta hormonal natural.

Dosis habitual	50–100 mcg, 1–2 veces al día	Duración sugerida	Ciclos según objetivo; vida media muy corta
Dosis mínima	50 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente y embarazo; trastornos hipofisarios sin control.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en fertilidad o salud hormonal, con valoración endocrina previa.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

PT-141 (Bremelanotida) · Agonista de melanocortina · deseo sexual

Qué es. Agonista de los receptores de melanocortina con uso aprobado para el deseo sexual hipoactivo; actúa a nivel del sistema nervioso central.

Cómo funciona. Activa el receptor MC4R en el cerebro, aumentando la excitación y el deseo sexual por una vía neurológica —no vascular— en ambos sexos.

Beneficios

- Aumento del deseo y de la excitación sexual.
- Útil en disfunción eréctil que no responde a inhibidores de PDE5.
- Efecto independiente de la estimulación directa.

Dosis habitual	0.5–2 mg, 45 min–2 h antes de la actividad	Duración sugerida	Uso puntual, no diario
Dosis mínima	0.5 mg (máx. ~8/mes)	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Hipertensión no controlada y enfermedad cardiovascular; puede elevar la presión y causar náusea o rubor.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con bajo deseo o disfunción sexual y presión bien controlada; no apto con enfermedad cardiovascular significativa.

FUNCIÓN COGNITIVA Y NEUROPROTECCIÓN · Enfoque, ánimo y resiliencia

Semax · Heptapéptido nootrópico · neuroprotección

Qué es. Péptido derivado de un fragmento de la ACTH, usado como nootrópico y neuroprotector, típicamente por vía intranasal.

Cómo funciona. Aumenta los factores neurotróficos BDNF y NGF y modula los sistemas de dopamina y serotonina, con efecto neuroprotector.

Beneficios

- Mejora del enfoque, la memoria y la claridad mental.
- Apoyo a la recuperación neurológica.
- Mayor resistencia al estrés cognitivo.

Dosis habitual	300–600 mcg/día (solución 0.1%/1%)	Duración sugerida	Ciclos de 10–14 días
Dosis mínima	300 mcg/día	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución en trastornos psiquiátricos o con medicación neurológica.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos que buscan apoyo cognitivo puntual; revisar interacciones con criterio médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Beneficios por objetivo

Selank · Heptapéptido ansiolítico

Qué es. Péptido análogo de la tuftsina con efecto ansiolítico, sin sedación ni dependencia, de administración intranasal.

Cómo funciona. Modula los sistemas GABA y serotonina, equilibra citoquinas y eleva el BDNF, estabilizando el estado de ánimo.

Beneficios

- Reducción de la ansiedad sin somnolencia.
- Estabilización del ánimo y mejor manejo del estrés.
- Apoyo al enfoque y a la calidad del sueño.

Dosis habitual	250–500 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 10–14 días
Dosis mínima	250 mcg/día	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución junto a medicación psiquiátrica.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con estrés o ansiedad leve; valoración si hay tratamiento psiquiátrico en curso.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**